

**SIÊU ÂM 3D FIBROID MAPPING
LẬP BẢN ĐỒ U XƠ TỬ CUNG:
NỀN TẢNG MỚI ĐỊNH HƯỚNG
ĐIỀU TRỊ TRONG HỖ TRỢ SINH SẢN**

BS. Đặng Tuấn Anh

Trung Tâm hỗ trợ sinh sản – Bệnh viện đa khoa Tâm Anh



ĐẶT VẤN ĐỀ



70-80%

Phụ nữ bị UXTC trong suốt cuộc đời, tăng theo tuổi. *ASRM 2017, Rezk 2023, SWHR 2026*

=>Triệu chứng lâm sàng: Ra máu TC bất thường (AUB), đau vùng chậu, ảnh hưởng đến thai kỳ...và **vô sinh**



5-10%

Vô sinh liên quan đến UXTC *Kupesic 2019, Emma 2023*

=> UXTC ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản?

NATIONAL MENSTRUAL HEALTH AWARENESS MONTH 2026

1 in 5

students have missed school due to their period.

70-80%

women will be diagnosed with uterine fibroids by age 50.

4-11

years is the average amount of time women wait to receive an endometriosis diagnosis.

1 in 3

women experience heavy menstrual bleeding.

The
FIBROID
FOUNDATION



Infertility in patients with uterine fibroids: a debate about the hypothetical mechanisms

Emma E. Don^{1,2,*}, Velja Mijatovic^{1,2}, and Judith A.F. Huirne^{1,2}

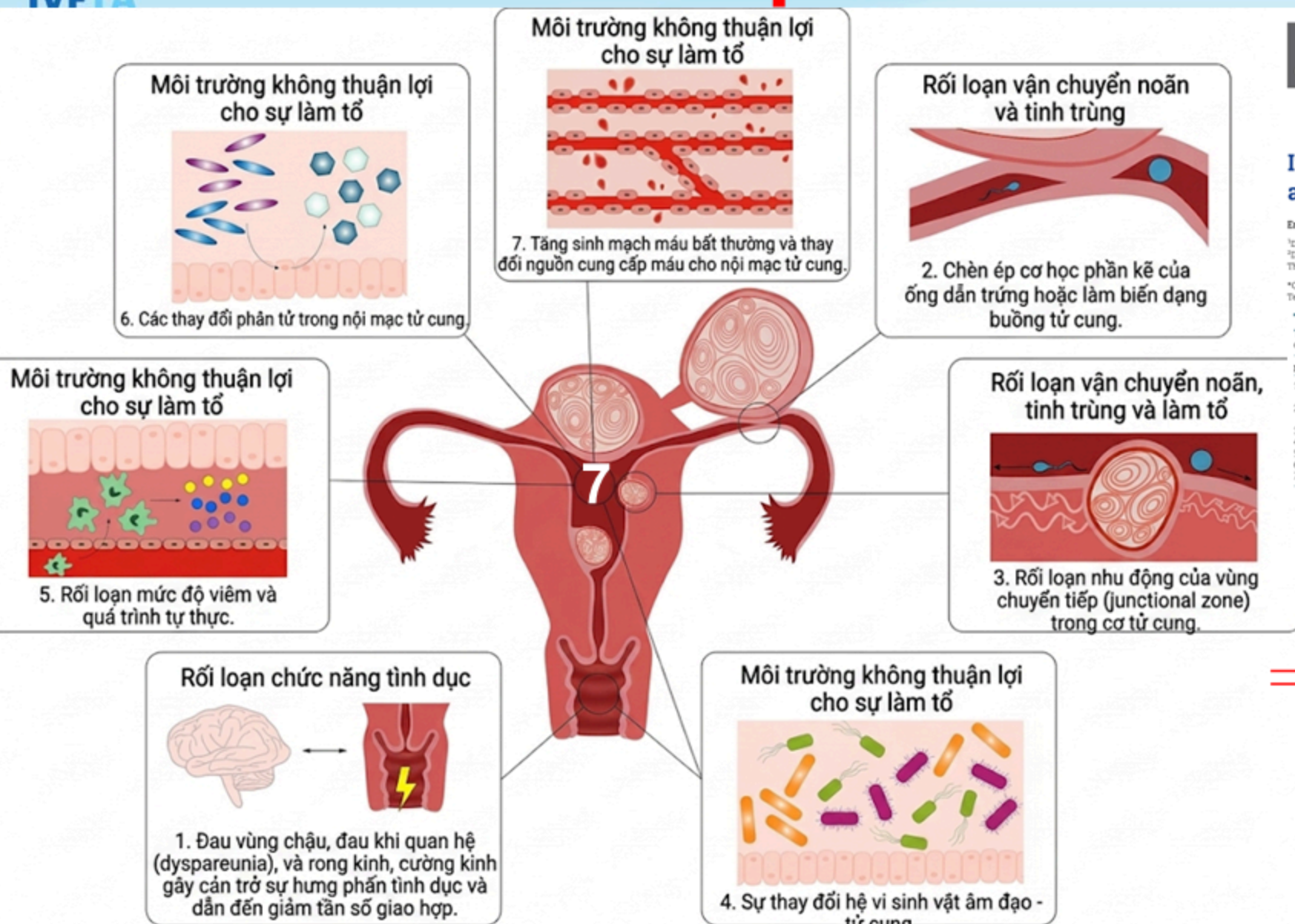
¹Department of Obstetrics and Gynaecology, Amsterdam UMC location Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands

²Department of Obstetrics and Gynaecology, Amsterdam UMC, University of Amsterdam, Amsterdam Reproduction and Development, Amsterdam, The Netherlands

*Correspondence address: Department of Obstetrics and Gynaecology, Amsterdam UMC, De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands.
 Tel: +31-20-566-9111; E-mail: e.e.don@amsterdamumc.nl <https://orcid.org/0000-0002-0782-4578>

Table 1. Seven postulated hypotheses on the underlying mechanisms that could be responsible for the detrimental effect of fibroids on fertility.

Mechanism	Stage of fertility
1. Pelvic pain, dyspareunia, and prolonged and heavy menstrual bleeding interfere with sexual arousal and, as a consequence, the frequency of intercourse	Sexual dysfunction
2. Physical compression of the interstitial part of the fallopian tubes or deformation of uterine cavity	Disturbed oocyte and sperm transport
3. Disturbed peristalsis of the junctional zone in the myometrium	Detrimental environment for implantation
4. Changes in vagino-uterine microbiome	
5. Disturbed levels of inflammation and autophagy	
6. Molecular changes in the endometrium	
7. Aberrant angiogenesis and altered endometrial blood supply	



⇒ UXTC có thể gây vô sinh và thất bại làm tổ

ẢNH HƯỞNG CỦA U XƠ TỬ CUNG ĐẾN KẾT CỤC IVF

DỮ LIỆU META-ANALYSIS (Pritts EA, et al., 2009)

1. TÁC ĐỘNG CỦA U XƠ THEO VỊ TRÍ

Kết quả được biểu thị dưới dạng Relative Risk (RR) so với nhóm không có u xơ (RR = 1.0)

6.090 phụ nữ mong con & làm IVF

KẾT CỤC	RELATIVE RISK (RR) [95% CI]		
	U xơ dưới niêm mạc (SM)	U xơ trong cơ (IM)	U xơ dưới thanh mạc (SS)
Tỷ lệ có thai lâm sàng	0.363 (0.179–0.737)	0.810 (0.596–1.102)	0.897 (0.800–1.004)
Tỷ lệ làm tổ (Implantation)	0.283 (0.123–0.649)	0.684 (0.503–0.930)	0.792 (0.696–0.901)
Thai tiến triển / Sinh sống	0.318 (0.119–0.850)	0.703 (0.532–0.930)	0.780 (0.690–0.883)
Sảy thai tự nhiên		1.678 (1.373–2.051)	1.747 (1.226–2.489)
Sinh non	– (Chưa có dữ liệu)	1.357 (0.607–3.036)	2.767 (0.797–9.608)



**U XƠ DƯỚI NIÊM MẠC
LÀM GIẢM MẠNH KHẢ NĂNG LÀM TỔ VÀ
TỶ LỆ SINH SỐNG**

- Giảm ~72% tỷ lệ làm tổ (RR 0.283)
- Giảm ~68% tỷ lệ thai tiến triển / sinh sống (RR 0.318)
- Tăng nguy cơ sảy thai tự nhiên ~68% (RR 1.678)



**HIỆU QUẢ MYOMECTOMY
Ở U XƠ DƯỚI NIÊM MẠC**

So với không mổ (u xơ trong buồng vẫn còn)
Tăng gấp đôi tỷ lệ có thai lâm sàng
RR 2.034 (95% CI 1.080–3.832; p = 0.028)

KẾT LUẬN LÂM SÀNG



U xơ dưới niêm mạc: ảnh hưởng xấu rõ rệt → điều trị (bóc u qua soi buồng tử cung) trước IVF.



U xơ trong cơ: ảnh hưởng mức độ trung bình → cân nhắc cá thể hóa.



U xơ dưới thanh mạc: không ảnh hưởng đáng kể đến kết cục sinh sản.

UTERINE FIBROIDS

Fibroids and infertility: an updated systematic review of the evidence

Elizabeth A. Pritts, M.D.,^a William H. Parker, M.D.,^b and David L. Olive, M.D.^a

^a Wisconsin Fertility Institute, Middleton, Wisconsin; and ^b Department of Obstetrics and Gynecology, University of California, Los Angeles, California

⇒ **Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào vị trí ??**

Nghịch lý trong điều trị ?

Có nên mổ bóc UXTC ?



✓ Lợi ích lâm sàng

Phẫu thuật bóc u xơ **dưới niêm mạc** giúp cải thiện rõ rệt tỷ lệ có thai lâm sàng trong chu kỳ IVF.

⚠️ Rủi ro "Con dao hai lưỡi"

Tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương lớp niêm mạc đáy, dẫn đến hệ quả dính buồng tử cung (IUA).

Tỷ lệ dính buồng tử cung (IUA): 7.5 % - 20%

[Pietro 2022](#)

Chúng ta cần một công cụ chẩn đoán hình ảnh
"Trực Quan" để cá thể hóa điều trị ?

Lập Bản Đồ UXTC Là Gì?

- **SÂ 2D/3D/MRI** dựng lại hình ảnh 3 chiều.
- Xác định **vị trí, số lượng, kích thước, liên quan** của UXTC với cơ tử cung và NMT.

Review Article

2022

<http://dx.doi.org/10.1590/0100-3984.2022.0048>

Reporting of uterine fibroids on ultrasound examinations: an illustrated report template focused on surgical planning

Relato de miomas uterinos em exames de ultrassonografia: um modelo de relatório ilustrado com foco no planejamento cirúrgico

Michel Santos Palheta^{1,a}, Francisco das Chagas Medeiros^{1,b}, Ana Roberta Gomes Severiano^{2,c}

1. Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, CE, Brazil. 2. Centro Universitário Inta (Uninta), Sobral, CE, Brazil.

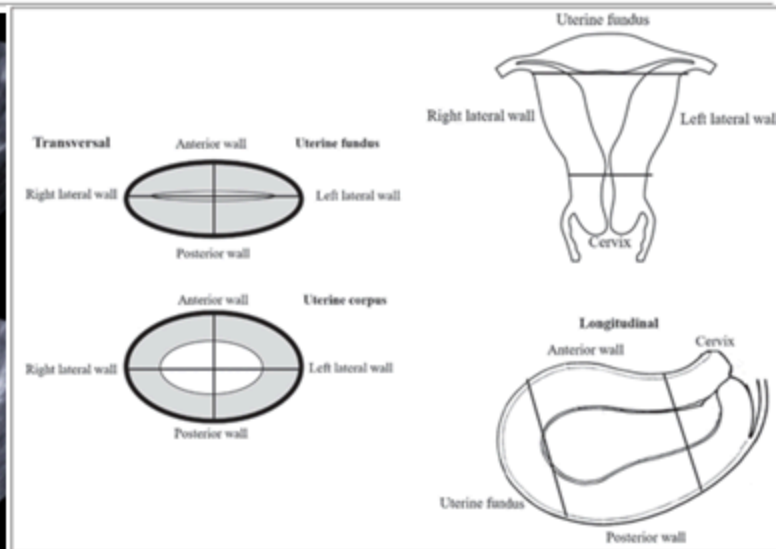
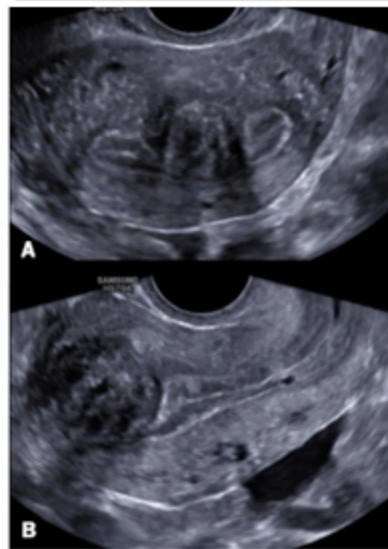
Correspondence: Dr. Michel Santos Palheta. Clínica Michel Palheta. Avenida Dom José Tupinambá da Frota, 2020, Centro. Sobral, CE, Brazil, 62010-290. Email: drpalheta@hotmail.com.

a. <https://orcid.org/0000-0001-8297-6311>; b. <https://orcid.org/0000-0001-5091-6015>; c. <https://orcid.org/0000-0003-0604-7398>.

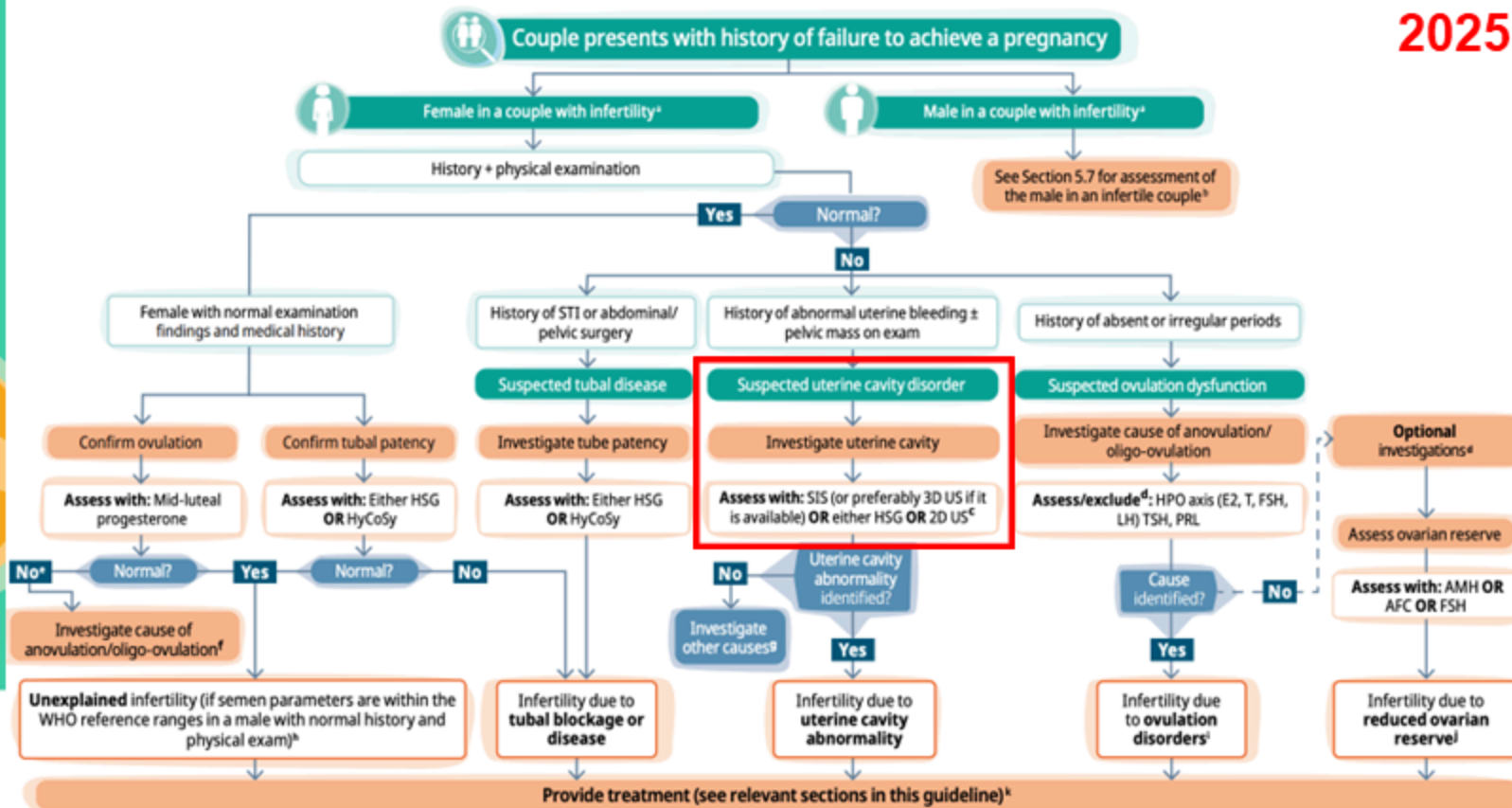
Received 19 April 2022. Accepted after revision 4 August 2022.

How to cite this article:

Palheta MS, Medeiros FC, Severiano ARG. Reporting of uterine fibroids on ultrasound examinations: an illustrated report template focused on surgical planning. Radiol Bras. 2023 Mar/Abr;56(2):86-94.

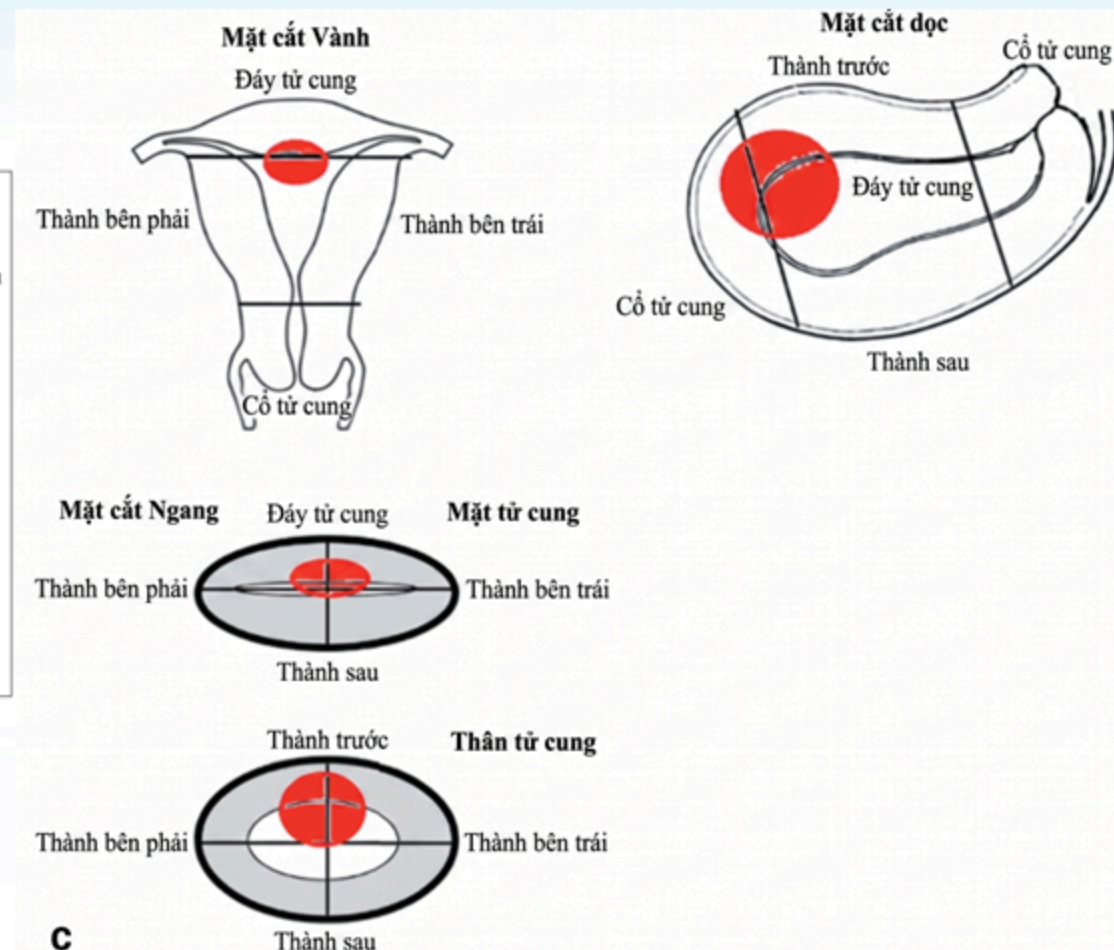
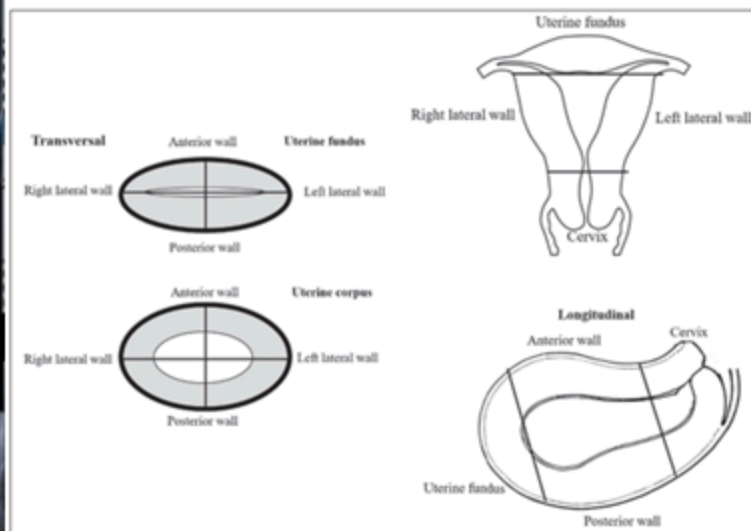
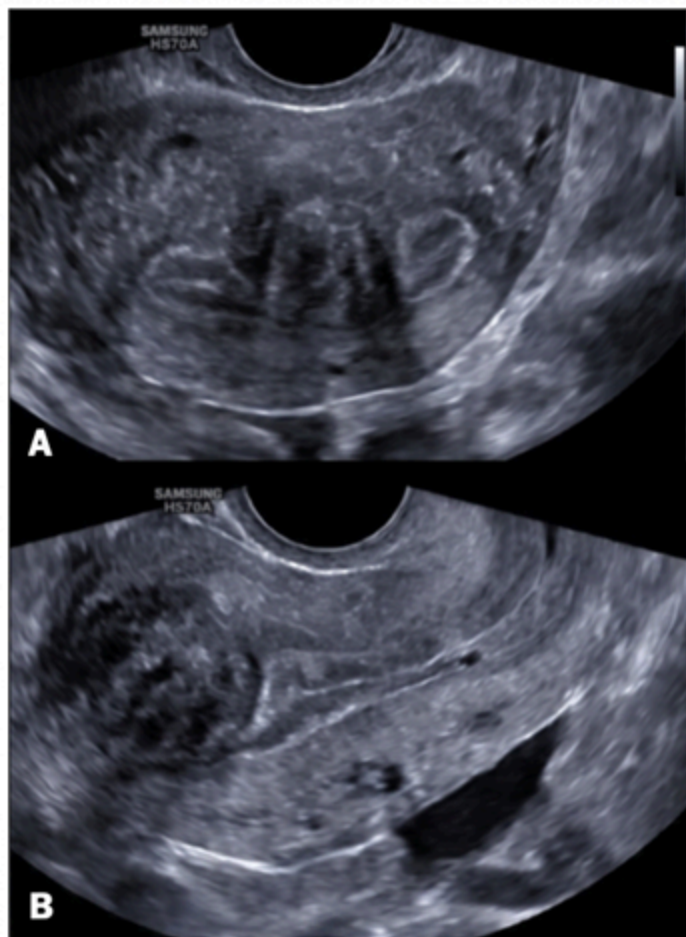


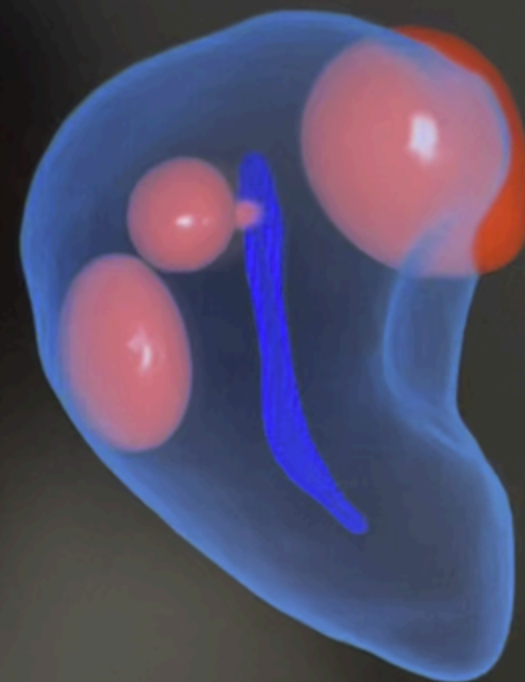
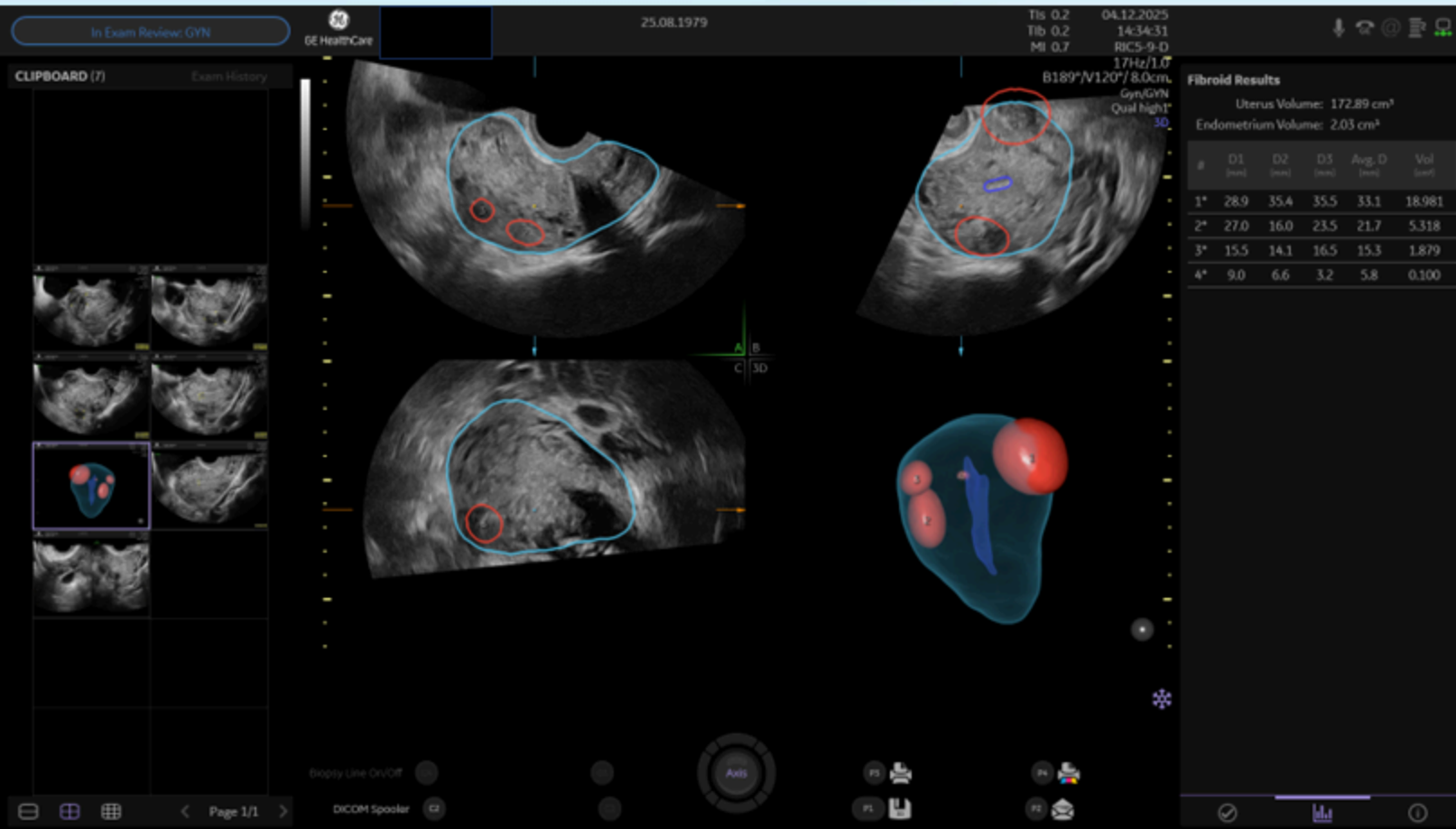
Guideline for the prevention, diagnosis and treatment of infertility



WHO 2025: SIS và SÂ 3D được ưu tiên hàng đầu để đánh giá BTC hơn HSG

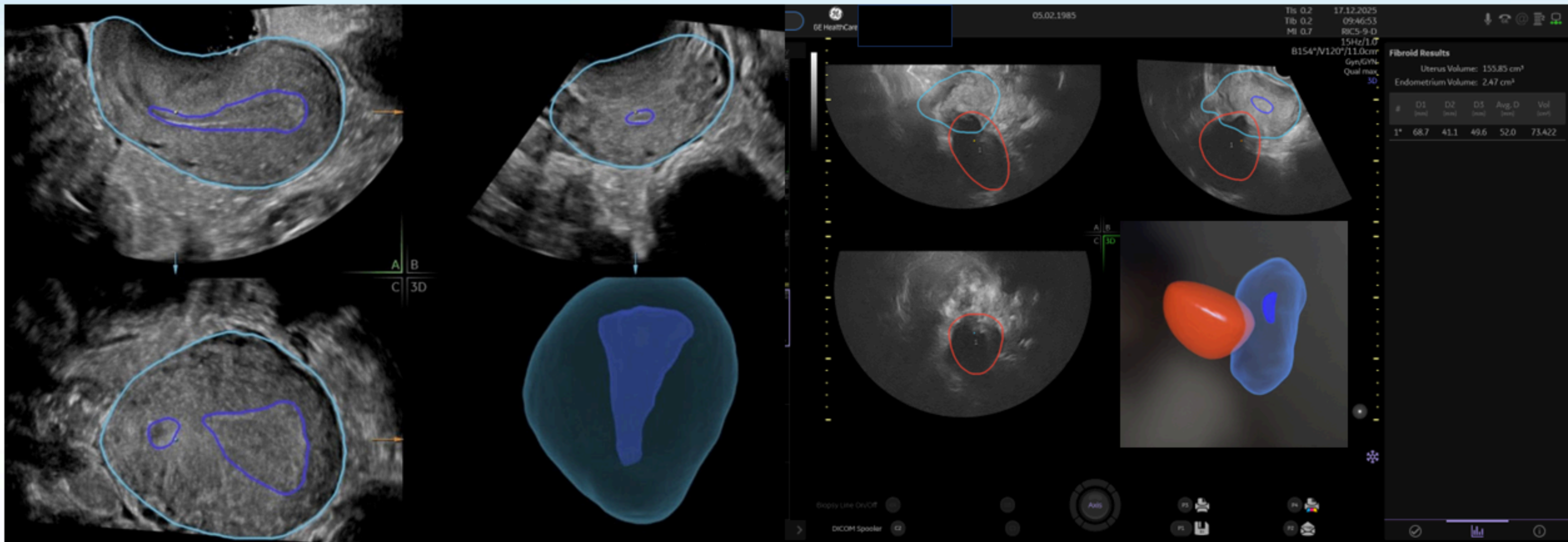
TỔNG QUAN





Fibroid Mapping Tool – AI: Quét nhận diện BTC và dựng bản đồ u xơ 3D trực quan.

Tại IVFTA



Fibroid Mapping Tool – AI: Quét nhận diện BTC và dựng bản đồ u xơ 3D trực quan.

Tại IVFTA

The two FIGO systems for normal and abnormal uterine bleeding symptoms and classification of causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years: 2018 revisions

Malcolm G. Munro^{1,2,*} | Hilary O.D. Critchley³ | Ian S. Fraser⁴ | for the FIGO Menstrual Disorders Committee

Nhóm Dưới niêm mạc

(Hysteroscopy Zone)

- Type 0: Trong buồng TC (Có cuống).
- Type 1: < 50% nằm trong cơ TC.
- Type 2: ≥ 50% nằm trong cơ TC.

Nhóm Dưới thanh mạc

(Subserosal Zone)

- Type 5, 6, 7: Ấn ra ngoài thanh mạc (Ít ảnh hưởng IVF).
- Type 7: U xơ có cuống dưới thanh mạc.

Nhóm Trong cơ

(Intramural Zone - Vùng xám)

- Type 3: Chạm niêm mạc, 100% trong cơ.
- Type 4: Hoàn toàn trong cơ.

Nhóm Khác & Xuyên thành

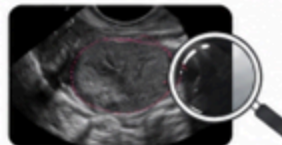
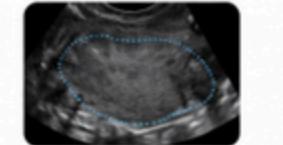
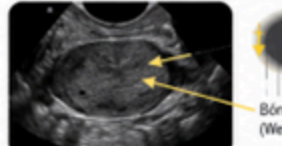
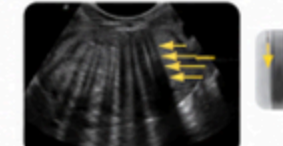
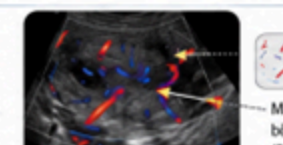
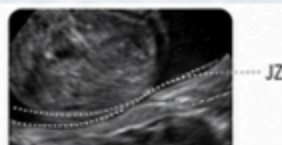
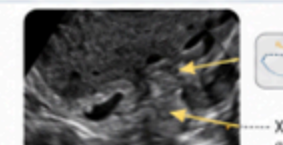
- Type 2-5: U xơ xuyên thành tiếp xúc cả niêm mạc và thanh mạc.
- Type 8: Tại cổ TC, dây chằng rộng...



Type	Location
0	100% intracavity
1	>50% intracavity
2	<50% intracavity
3	Contact endometrium, 100% intramural
4	100% intramural
5	<50% subserosa
6	>50% subserosa
7	100% subserosa
8	Others (cervical, broad ligament, parasitic, etc.)

Phân biệt U xơ (Fibroid) và Lạc nội mạc trong cơ (Adenomyosis)

PHÂN BIỆT SIÊU ÂM: U XƠ TỬ CUNG (FIBROID) VS LẠC NỘI MẠC TRONG CƠ (ADENOMYOSIS)

TIÊU CHÍ	U XƠ TỬ CUNG (FIBROID)	LẠC NỘI MẠC TRONG CƠ (ADENOMYOSIS)
 Ranh giới	Rõ ràng, có giả vỏ bao 	Mờ nhạt, khuếch tán 
 Bóng lưng	Bóng lưng viền (Edge shadow)  Bóng lưng trung tâm yếu (Weak central shadow)	Bóng màn trúc (Venetian blind)  Bóng màn trúc (Venetian blind Artifact)
 Cấu trúc mạch máu	Mạch máu bao quanh viền (Bridging vessels)  Mạch máu ngoại vi (Peripheral flow)	Mạch máu xuyên tổn thương (Translesional flow)  Mạch máu khuếch tán bên trong (Diffuse internal vessels)
 Vùng chuyển tiếp JZ	Đẩy lệch nhưng nguyên vẹn  JZ	Dày lên, đứt đoạn, xâm lấn  JZ dày, không đều (Disrupted) Xâm lấn (Invasion)

ULTRASOUND in Obstetrics & Gynecology
2015

Consensus Statement | [Free Access](#)

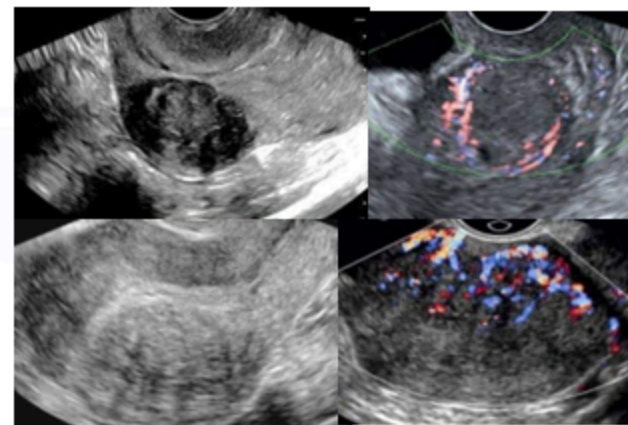
Terms, definitions and measurements to describe sonographic features of myometrium and uterine masses: a consensus opinion from the Morphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA) group

T. Van den Bosch, M. Dueholm, F.P.G. Leone, L. Valentin, C.K. Rasmussen, A. Votino, D. Van Schoubroeck, C. Landolfo, A.J.F. Installé, S. Guerriero, C. Exacoustos ... See all authors

First published: 04 February 2015 | <https://doi.org/10.1002/uog.14806> | [VIEW METRICS](#)

27,16-61,5% NB đồng mắc UXTC và

LNMTTC trong cơ Dakhly 2016, Zannoni 2020

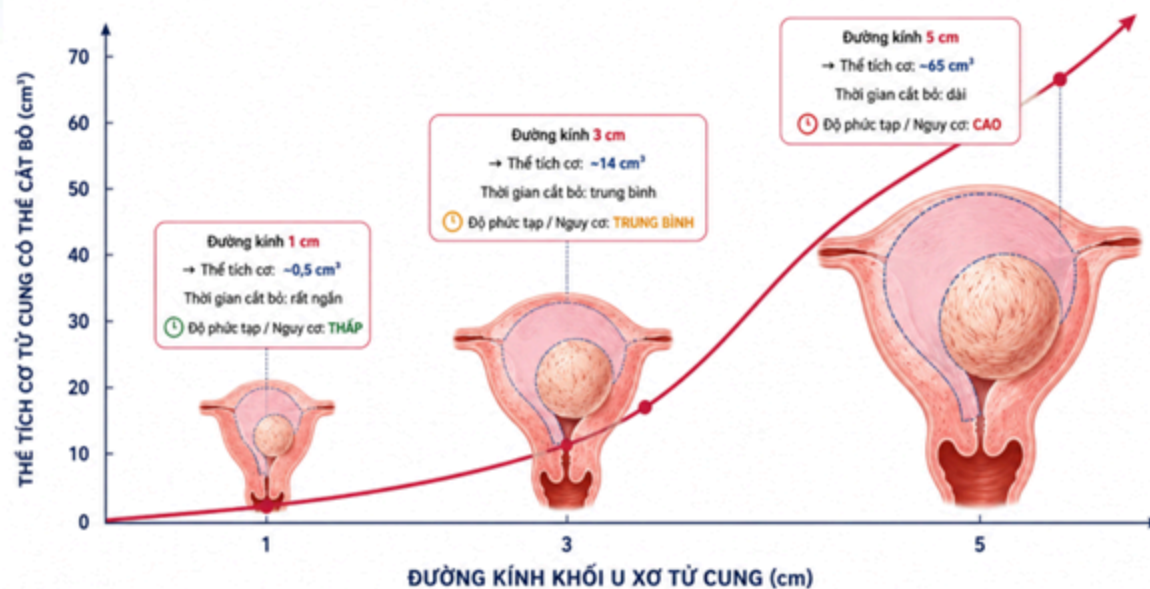


⇒ Chẩn đoán đúng quyết định chính xác can thiệp

Mapping UXTC: Sức mạnh đến từ SÂ 3D + SIS

- **Siêu âm 3D:** Mặt cắt vành, nhận diện mối tương quan không gian UXTC và BTC đặc biệt là thể tích UXTC.
- **Siêu âm SIS (Sonohysterography):** UXTC dưới niêm. Độ nhạy đạt 92% và độ đặc hiệu 90% (so với 64% và 90% của siêu âm 2D thông thường) [WHO 2025](#)

Ảo ảnh của đường kính



V_{UXTC} **cắt tăng cấp số nhân** so với ĐK

=> Đo V tiên lượng nguy cơ chảy máu, tổn thương cơ, thời gian phẫu thuật

=> Loại bỏ "vùng mù" của siêu âm 2D

Mapping UXTC: Đo lường khoảng cách an toàn (Lesion-free margin)

- Từ bờ UXTC đến thanh mạc (Myometrial Free Margin)
- Từ bờ UXTC đến nội mạc.
- **Giá trị lâm sàng :**

LOẠI DỤNG CỤ NĂNG LƯỢNG	KHOẢNG CÁCH AN TOÀN TỐI THIỂU (ĐỀ XUẤT)	MỨC ĐỘ RỦI RO BÔNG NHIỆT
Dao lạnh (Mechanical / Cold loop)	$\geq 3 \text{ mm}^*$	Không có rủi ro nhiệt
Dao lưỡng cực (Bipolar)	$\geq 3 - 5 \text{ mm}^*$	Thấp đến trung bình
Dao đơn cực (Monopolar)	$\geq 5 - 10 \text{ mm}^*$	Cao (cần khoảng cách dày hơn)

* Giá trị đề xuất dựa trên đặc tính lan truyền nhiệt và kinh nghiệm lâm sàng.
Cần đánh giá cá thể hóa từng bệnh nhân.

=> Quyết định mức độ an toàn, giúp PT viên tránh thủng BTC.



Journal of Minimally Invasive Gynecology
Volume 22, Issue 5, July–August 2015, Pages 792–798



Original Article

Is Cold Loop Hysteroscopic Myomectomy a Safe and Effective Technique for the Treatment of Submucous Myomas With Intramural Development? A Series of 1434 Surgical Procedures

Ivan Mazzone MD^a, Alessandro Favilli MD^b, Mario Grasso MD^a, Stefano Horvath MD^a, Gian Carlo Di Renzo MD, PhD^b, Sandra Gerli MD^b  

Uterine fibroids

Should the myometrial free margin still be considered a limiting factor for hysteroscopic resection of submucous fibroids? A possible answer to an old question [Mind Map](#) [Interpret](#) [My AI](#)

Paolo Casadio M.D.^a  , Aly M. Youssef M.D.^a, Emanuela Spagnolo M.D.^a, Maria Antonietta Rizzo M.D.^a, Maria Rita Tolamo M.D.^a, Denise De Angelis M.D.^a, Elena Marra M.D.^a, Tullio Ghi M.D.^a, Luca Savelli M.D.^a, Antonio Farina M.D.^a, Giuseppe Pelusi Prof.^a, Ivan Mazzone M.D.^b

November 2001, Vol. 8, No. 4 The Journal of the American Association of Gynecologic Laparoscopists

Changes in Myometrial Thickness during Hysteroscopic Resection of Deeply Invasive Submucous Myomas

Jehn-Hsiahn Yang, M.D., and Bao-Liang Lin, M.D., Ph.D.

Mapping UXTC: Tích hợp thang điểm STEPW cho nhóm FIGO 0-2

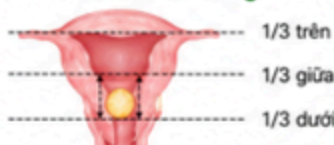
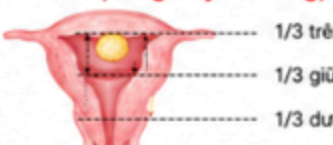
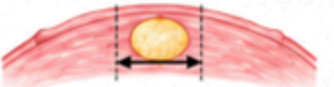
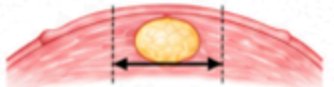
ORIGINAL ARTICLE • Volume 19, Issue 5, P375-380, September-October, 2012

[Download Full Issue](#)

A New System to Classify Submucous Myomas: A Brazilian Multicenter Study

Ricardo Bessil Losmar, MD, PhD^{1,2,3} • Bernardo Portugal Losmar, MD⁴ • Roger Keller Celeste, DS, PhD⁵ • Daniela Baltar da Rosa, MD⁶ • Daniela de Botista Depes, MD⁶ • Reginaldo Guedes Coelho Lopes, MD, PhD⁶

Article Info

TIÊU CHÍ (THÔNG SỐ STEPW)	0 ĐIỂM	1 ĐIỂM	2 ĐIỂM
S Size (Kích thước lớn nhất)	≤ 2 cm 	> 2 cm đến 5 cm 	> 5 cm 
T Topography (Vị trí theo chiều dọc)	1/3 dưới tử cung  1/3 trên 1/3 giữa 1/3 dưới	1/3 giữa tử cung  1/3 trên 1/3 giữa 1/3 dưới	1/3 trên (vùng đáy tử cung)  1/3 trên 1/3 giữa 1/3 dưới
E Extension (Diện bám của chân u)	≤ 1/3 thành tử cung 	> 1/3 đến 2/3 thành tử cung 	> 2/3 thành tử cung 
P Penetration (Độ thâm xuyên vào cơ)	Toàn bộ khối u nằm trong buồng (Type 0) 	Phần lớn u nằm trong buồng (≤ 50% trong cơ – Type 1) 	Phần lớn u nằm trong cơ (> 50% trong cơ – Type 2) 
W Wall (Thành tử cung bị tổn thương)	Thành trước hoặc Thành sau 	Thành bên (trái/phải) 	Cả hai thành (hoặc đa u) 
Tổng điểm STEPW = S + T + E + P + W (0 – 10 điểm) → 0 – 4 điểm: Nguy cơ thấp (Nhóm I) 5 – 6 điểm: Nguy cơ trung bình (Nhóm II) 7 – 10 điểm: Nguy cơ cao (Nhóm III)			

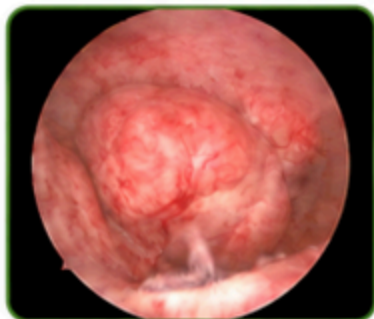
A New System to Classify Submucous Myomas: A Brazilian Multicenter Study

Ricardo Bessil Losmar, MD, PhD ^{1,2,3,4} • Bernardo Portugal Losmar, MD ⁵ • Roger Keller Celeste, DS, PhD ⁶ • Daniela Baltar da Rosa, MD ⁷ • Daniella de Botista Depes, MD ⁸ • Reginaldo Guedes Coelho Lopes, MD, PhD ⁹

Affiliations & Notes [Article Info](#)

Mapping UXTC: Tích hợp thang điểm STEPW cho nhóm FIGO 0-2

Nhóm I (0–4 điểm)



ĐẶC ĐIỂM

Phẫu thuật đơn giản, thời gian mổ ngắn, nguy cơ biến chứng thấp.



TIỀN LƯỢNG

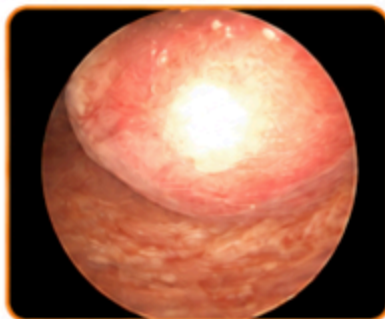
Tỷ lệ cắt sạch u hoàn toàn trong 1 thì đạt gần như 100%.



Tổng điểm: 0 – 4 điểm

Phân loại: Nguy cơ thấp (Nhóm I)

Nhóm II (5–6 điểm)



ĐẶC ĐIỂM

Thời gian mổ trung bình – dài, nguy cơ quá tải dịch trung bình.



TIỀN LƯỢNG

Có thể cần mổ sang thì 2 nếu thời gian mổ kéo dài hoặc có nguy cơ quá tải dịch truyền.



Tổng điểm: 5 – 6 điểm

Phân loại: Nguy cơ trung bình (Nhóm II)

Nhóm III (7–10 điểm)



ĐẶC ĐIỂM

Thời gian mổ dài, nguy cơ quá tải dịch và biến chứng cao.



TIỀN LƯỢNG

Tỷ lệ phải mổ nhiều hơn 1 thì (mổ lại thì 2 sau vài tuần) để lấy hết u là rất lớn. Nên cân nhắc phương pháp phẫu thuật thay thế hoặc điều trị nội khoa hỗ trợ trước mổ.



Tổng điểm: 7 – 10 điểm

Phân loại: Nguy cơ cao (Nhóm III)

Mapping UXTC: FIGO 3-8 ?

NC quan sát hồi cứu (2020 – 2025) tại Ý trên 94 phụ nữ vô sinh < 40 tuổi chia thành 3 nhóm:

Nhóm A (n=17): FIGO 0-2 Nội soi BTC bóc u.

Nhóm B (n=39): FIGO 3-8 mổ mở (laparotomy) bóc u.

Nhóm C (n=38): UXTC như nhóm B nhưng không phẫu thuật.

NHÓM A (N=17)

U xơ dưới niêm mạc (FIGO 0-2)

LÂM TỔ (IR)

41%

THAI KỲ (CPR)

35.2%



Kháng định hiệu quả tối ưu của nội soi buồng tử cung trong bảo tồn sinh sản.

NHÓM B vs C (N=77)

U xơ trong cơ (FIGO 3-8, >3cm)

Tỷ lệ lâm tổ (IR)

B: 31% vs C: 12.9%

Thai lâm sàng (CPR)

B: 28.1% vs C: 7.8%



Phẫu thuật giúp tăng tỷ lệ mang thai lên gấp 3.6 lần ($p < 0.05$).



Journal of
Clinical Medicine

2026



Article

A Proposed Model of a Pragmatic Surgical Approach in Women Affected by Uterine Fibroids Undergoing IVF: A “Real Practice” Experience

Domenico Antonaci , Francesco Galanti , Roberta Dall’Alba , Eleonora Benedetti, Andrea Rago, Laura Antonaci, Donatella Miriello and Rocco Rago 

	0	Peduncolated / intracavitary	Always remove by hysteroscopy (<5 cm)
	1	< 50% intramural	
	2	≥ 50% intramural	
	3	Contacts endometrium, 100% intramural	Up to 3 fibroids < 3 cm → no surgery
	4	Intramural	
	5	Subserosal ≥ 50% intramural	
	2 – 5	Submucosal and subserosal, each with less than half the diameter in the endometrial and peritoneal cavities, respectively	If 3 fibroids with 1 > 3 cm → consider surgery If 3 fibroids with 2 > 3 cm → surgery
	6	Subserosal <50% intramural	
	7	Subserosal pedunculated	
	8	Cervical	If supracervical ≥ 3 cm → surgery

Không có ngưỡng kích thước tuyệt đối; vị trí u xơ quan trọng hơn kích thước trong tiên lượng sinh sản.



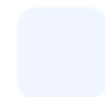
Mổ nội soi ổ bụng bóc u (Laparoscopic Myomectomy)

- Được xem là "**Tiêu chuẩn vàng**" trong phẫu thuật bảo tồn sinh sản đối với u xơ FIGO 3 và 4.
- Mang lại kết quả sinh sản tương đương mổ hở.
- Giúp bệnh nhân **phục hồi nhanh** và ít đau đớn hơn so với các phương pháp truyền thống.



HIFU (Sóng siêu âm hội tụ)

- Phương pháp **hoàn toàn không xâm lấn** (không vết mổ, không chảy máu), dùng nhiệt hoại tử u.
- Đã được **FIGO** đưa vào hướng dẫn lâm sàng chính thức.
- Rút ngắn thời gian phục hồi; bệnh nhân có thể chuẩn bị mang thai chỉ sau **3 tháng**.

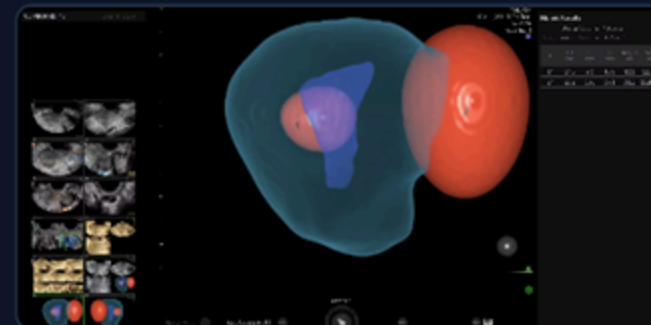


RFA (Đốt sóng cao tần qua kim)

- Tiếp cận qua đường âm đạo dưới hướng dẫn siêu âm, đưa năng lượng trực tiếp vào khối u.
- Hiệu quả giảm thể tích khối u rất tốt (giảm trung bình **>50% thể tích** sau can thiệp).
- Cải thiện rõ rệt các triệu chứng lâm sàng và bảo tồn cấu trúc cơ tử cung.

Vai trò của 3D Fibroid Mapping

Việc đo lường chính xác khoảng cách từ vỏ khối u đến nội mạc (**Inner margin**) và thanh mạc (**Outer margin**) giúp các chuyên gia cá thể hóa quyết định: khối u nào mổ nội soi an toàn, khối u nào phù hợp dùng kim đốt RFA hay dùng sóng HIFU để **tránh tổn thương buồng tử cung**.



Bệnh nhân Vô sinh + Siêu âm nghi ngờ u xơ

Mapping (FIGO + MUSA + Volume)

Dưới niêm mạc (FIGO 0-2)

Tính điểm STEPW

**Phẫu thuật soi buồng tử cung
(Nếu STEPW ≤ 6)**

Trong cơ (FIGO 3-5)

Kích thước > 4cm? / Đa u xơ?

CÓ

**Nội soi ổ bụng / RFA /
HIFU**

KHÔNG

Trực tiếp IVF

Dưới thanh mạc (FIGO 6-7)

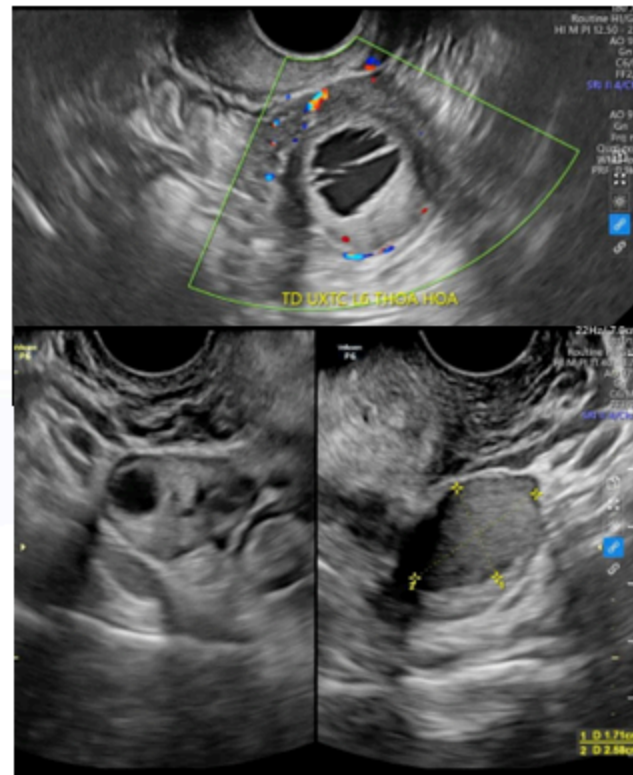
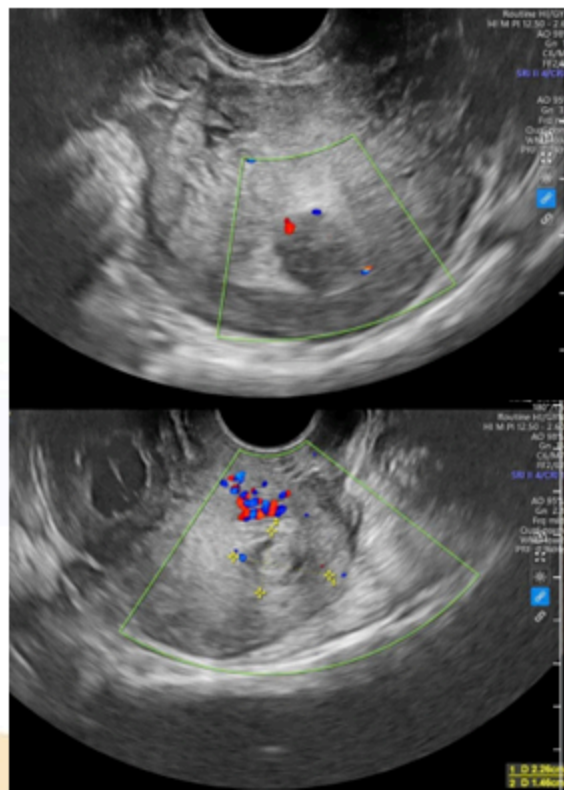
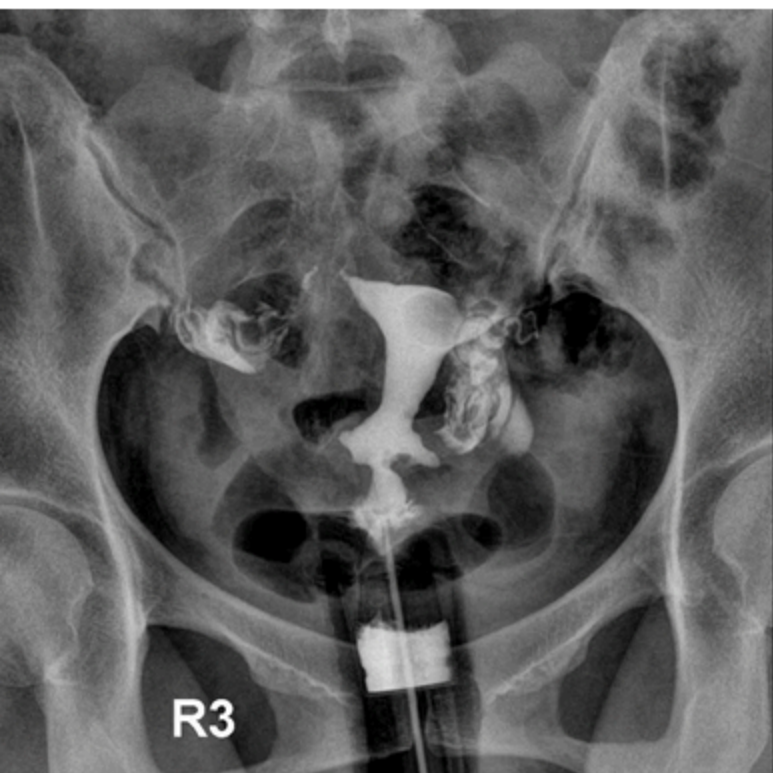
Không ảnh hưởng IVF

Trực tiếp IVF

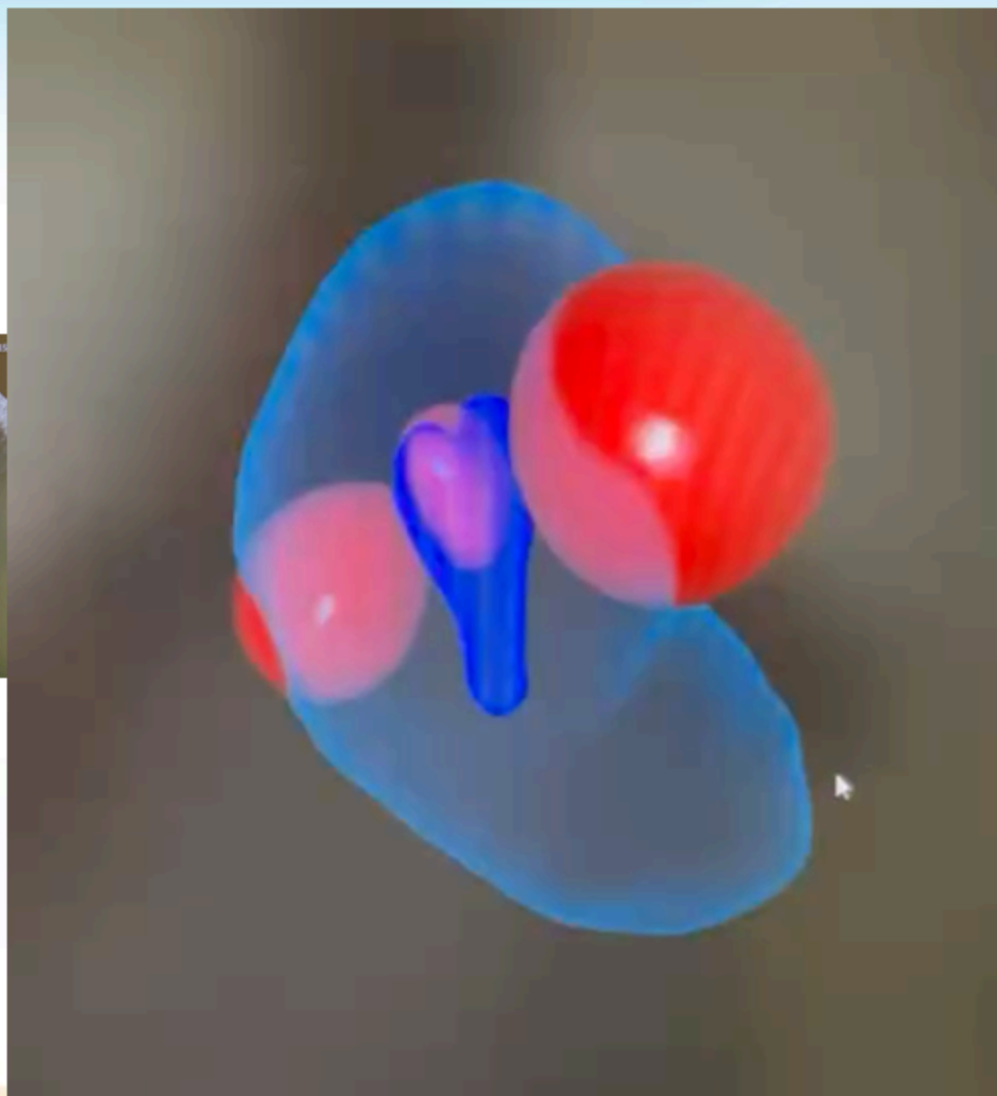
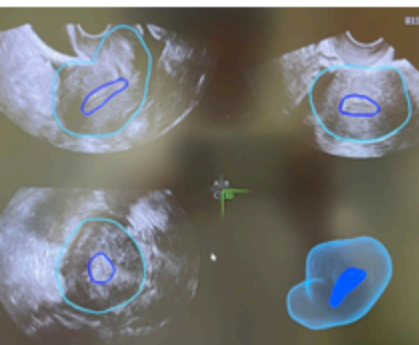
KH 35t para 1001, 1 lần mổ đẻ, mong con 1 năm.

Xét nghiệm: AMH 0.96 ng/ml

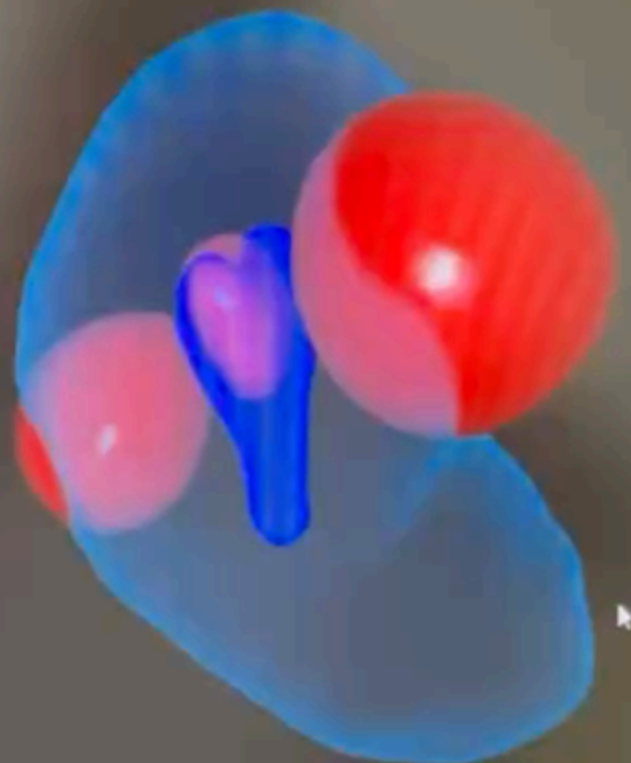
Siêu âm: Đa u xơ tử cung + LNMTC trên buồng trứng trái



BÁO CÁO CA LÂM SÀNG



Tiêu chí STEPW	Đánh giá	Điểm
S (Size)	20 mm (≤ 2 cm)	0
T (Topography)	1/3 giữa tử cung (ước lượng từ 3D)	1
E (Extension)	Chân bám $\leq 1/3$ thành tử cung (ước lượng)	0
P (Penetration)	FIGO Type 1 Thành trước/sau	1
W (Wall)	(không phải thành bên)	0
Tổng điểm STEPW		2 điểm



Giá trị của dựng hình 3D:

- ✓ **STEPW** chỉ đánh giá **một u** dưới niêm.
- ✓ **Mô hình 3D** đánh giá **toàn bộ** gánh nặng bệnh lý (đa u xơ, vị trí không gian, FIGO khác nhau, lạc nội mạc tử cung), giúp lập kế hoạch phẫu thuật toàn diện hơn.

=> Phẫu thuật nội soi + Nội soi ổ bụng xử trí theo tổn thương

ta Tâm Anh Hospital

PHIẾU PHẪU THUẬT/ THỦ THUẬT

Họ tên người bệnh: Tuổi: 35 Tuổi Giới tính: Nữ
 Khoa: Gây mê hồi sức Phòng:
 Vấp viện lúc: 07 giờ 35 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2025
 Phẫu thuật/ thủ thuật lúc: 11 giờ 25 phút, ngày 22 tháng 05 năm 2025
 Chẩn đoán:
 - Trước phẫu thuật/ thủ thuật: U xơ tử cung + U lạc nội mạc tử cung buồng trứng trái (D27) (D25)
 - Sau phẫu thuật/ thủ thuật: Đa u xơ tử cung + U lạc nội mạc tử cung buồng trứng trái (D27) (D25)
 - Phương pháp phẫu thuật/ thủ thuật: Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ + Nội soi ổ bụng bóc u.
 - Phân loại PT/TT: Loại 1
 - Phương pháp vô cảm: Gây mê Mask thành quần
 - PTV/ Người thực hiện chính: PGS.TS.BS. LÊ HOÀNG;
 - PTV/ Người phụ: BSKII. Phan Ngọc Quý; - BS. Đặng Tuấn Anh;
 - Bác sỹ gây mê hồi sức: BSKII. ĐỖ ANH MINH;
 - KTV gây mê: HOANG THỊ KIM LIEN; - KTV dụng cụ: NGUYỄN THANH CÔNG;

LƯỢC ĐỒ PHẪU THUẬT/ THỦ THUẬT

Sốt trùng rỗng rãi vùng bụng, âm hộ, âm đạo.

Thủ 1: Nội soi buồng tử cung

Bộc lộ cổ tử cung, đưa camera thấy ống cổ bình thường. Buồng tử cung thể tích bình thường, trong buồng có 01 u xơ có cuống ở phía đáy gần góc trái tử cung kích thước 1x1cm, vô nhân. Tiến hành cắt lấy u bằng bộ phẫu thuật buồng 2 cực, lấy bệnh phẩm gửi mô bệnh học.

Hồ vết mổ để cũ ở thành trước đoạn eo có khuyết lõm nhẹ và có ít mạch tăng sinh -> đốt bề mặt. Sau cắt kiểm tra buồng tử cung toàn vẹn, không chảy máu, quan sát niêm mạc bình thường, nhìn rõ 2 lỗ vòi tử cung.

Thủ 2: Nội soi ổ bụng

Chọc 03 trocar (2 cái 5mm ở rốn và hố chậu phải, trocar 10mm ở hố chậu trái). Kiểm tra ổ bụng sạch. Bề mặt gan không dính. Có 1 dấu mạc nối nhỏ dính lên thành bụng trước. Tử cung kích thước to. Thành trước có u xơ kích thước 3x4cm, đẩy lùi thành mạc (L6). Mặt sau tử cung dính vào trực tràng. Buồng trứng trái có nang chứa dịch nâu đen, dính vào thành chậu và mặt sau tử cung. Buồng trứng phải bình thường. Vòi tử cung 2 bên mềm mại tự do.

Tiến hành gỡ dính cùng độ sâu, gỡ dính mạc nối, gỡ dính buồng trứng trái- đốt lồng nang. Kiểm tra không thấy u xơ tử cung ở mặt sau và đáy. Tiến hành bóc u xơ tử cung mặt trước, lấy bệnh phẩm gửi mô bệnh học. Khâu cầm máu diện bóc u bằng chỉ vicryl 1.0 mũi X.

Kiểm tra không chảy máu. Bơm Xarix methylene 2 vòi tử cung thông. Rửa sạch ổ bụng. Đặt 01 dẫn lưu cùng độ sâu.

Hướng điều trị:

- Vòng kinh nhân tạo 01 chu kỳ
- Hẹn sạch kinh 2-3 ngày đến khám lại tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Các biến chứng hoặc diễn biến bất thường ngoài dự kiến trong quá trình phẫu thuật/ thủ thuật:

Không

BÁO CÁO CA LÂM SÀNG

02.08.1990 PKĐK Tâm Anh SÃ 2014
GA=21w5d



1. **Cảnh báo lâm sàng:** AI hiện chỉ là *Công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng (Clinical Decision Support)*, không thể thay thế bác sĩ.
2. Dễ **nhận diện sai ranh giới** khi tử cung bị biến dạng giải phẫu quá nặng, đa nhân xơ khổng lồ, hoặc chất lượng hình ảnh bị nhiễu do ảnh bóng lưng (acoustic shadowing).
3. AI thiếu khả năng tích hợp **bệnh sử toàn diện và các bệnh lý đi kèm** phức tạp.



**PROF. MICHAËL
GRYNBERG**

Trưởng khoa Y học sinh sản và Bảo tồn sinh sản
Bệnh viện Đại học Antoine-Béclère (Pháp).
KOL Quốc tế về Sản phụ khoa & Vô sinh.

LỢI ÍCH LÂM SÀNG CỦA FIBROID MAPPING TRONG IVF

"Thách thức lớn nhất trong đánh giá vô sinh là có một khảo sát tối ưu, chính xác mà không quá xâm lấn."

- 🎯 Lựa chọn **đúng đối tượng** cần can thiệp mổ.
- 🛡️ Tránh phẫu thuật bóc u "oan" gây **sẹo xơ tử cung**.
- 🚫 Hỗ trợ phương pháp **ít tổn thương nội mạc** nhất.

DẪN ĐẦU XU HƯỚNG BẢO TỒN SINH SẢN HIỆN ĐẠI

1

Fibroid Mapping 3D không chỉ là hình ảnh học, mà là **nền tảng cốt lõi** để ra quyết định trong Sản phụ khoa và HTSS trong tương lai.

2

- Tích hợp chuẩn **FIGO, MUSA và STEPW** giúp chuẩn hóa báo cáo, cá thể hóa phác đồ điều trị.

3

- Ứng dụng công nghệ mới (3D, AI) giúp tối ưu hóa hiệu quả IVF, bảo tồn chức năng sinh sản và tránh tổn thương tử cung không đáng có.

**Thank you
for your
attention**

See you next time,
have a great day!

